

物的禁忌。其中收载了许多食疗药膳方,其中药粥 42 种,药酒 75 种。明清时期,不少医家、志士、贤人都很重视收集、整理载于历代医著、宫廷或民间流传的食疗药膳的内容,撰写成不少专著发行于世。

近年来,由于人们的生活水平大幅度地提高,人们的平均寿命普遍增长,使医学发展的方向在原来临床医学的基础上,逐步向预防医学和康复医学方向发展。食疗药膳愈来愈受到人们的重视。保健食品和食疗药膳逐步向社会化和商品化方向发展。结合现代科研成果制成的具有治疗作用的食物、饮料,品种繁多,各具特色。既有适合糖尿病、肥胖者和心血管疾病患者服食的药膳食品,也有适合运动员、演员和矿工等服食的保健饮料,还有促进儿童健康发育或用于老人延年益寿的保健食品或药膳。中国药膳开始走向世界,不少药膳罐头和中药保健饮料、药酒等已销往国际市场。有的国家已经开设药膳餐厅。国际上一些学术界和工商界人士十分关注中国药膳这一特殊食品,希望能开展这方面的学术交流与技术合作。中国药膳将为世界人民的健康作出贡献。

四、药膳的特点

药膳是药物与食物的巧妙结合。它具有食物的作用,也具有药品的作用,但又不同于食品,也不同于药品。它的特点是:

(一) 以中医药理论为基础,辨证论治

药膳从其医疗意义来说,是中药学的一个组成部分。它是从中医学的阴阳五行、脏腑经络、辨证施治的理论为基础,按中医方剂学的组方原则和药物、食物的性能选配组合的。药膳的主要功能是以食物、药物的偏性来矫正脏腑功能的偏性,使之恢复正常。能减轻或消除热证的药物或食物一般属于寒性或凉性,如黄芩、板蓝根等食物,以偏凉之性,起到清热解毒的作用;给虚寒患者配膳,则应多用面粉、粳米、糯米等,以温中补虚。如当归生姜羊肉汤治血虚有寒腹痛,方中选用甘温的当归为主药,补血止痛,配以辛温的生姜,温中散寒;因病属虚证,故重用羊肉血肉有情之品温中补虚,三者合用而共奏温中补血、祛寒止痛之功。

药膳的施用是以中医的整体观念和辨证施治的理论为根据,按治病求本、扶正祛邪、调整阴阳、因时因地因人而治的治疗原则运用的。在用药和食物的选择上,必须依据辨证论治原则,在正确辨证的基础上,采取相应的治疗原则,选药组方或选食配膳,才能取得预期的效果。例如,当出现精神困倦、四肢软弱、短气懒言、头昏自汗、食欲减退、胃腹隐痛、便溏腹泻、舌质淡、舌苔白、脉缓无力等证候时,中医辨证为脾气虚证。这时就要应用健脾益气药膳。健脾益气药膳选用的中药有党参、白术、山药、大枣、茯苓、薏苡仁、莲米、芡实之类,食用的药膳有参枣米饭、山药汤圆、茯苓包子、益脾饼、大枣粥等。再加,同为咳嗽,对于风寒咳嗽以食用葱白粥为宜;对肺阴虚燥热的干咳,则宜用百合杏仁粥;风热咳嗽则应服贝母桑叶梨汁。应仔细辨证,充分了解各种咳嗽的寒、热、虚、实。只有有了正确的诊断,治疗才不会出现差错。同为虚证,气虚者宜食用牛肉、糯米、山药、党参以补气;血虚者宜食龙眼肉、当归以补血。

在运用辨证论治原则的时候,还应注意四时气候、地理环境对人的生理、病理的影响,在不同的季节选用不同的药膳。春宜升补;春天阳气初生,大地复苏,万物生发向上,内应肝脏,应根据春季的特性,因势利导,应用升补之法,充分调动人体的阳气,使气血调和,适宜食用首乌肝片、妙香舌片等药膳。夏宜清补;夏日炎热,火邪炽盛,万物繁茂,内应心脏,应根据夏令之时,人体脏腑气血旺盛,采用清淡、清热之品调节人体阴阳气血,适宜食用西瓜盅、荷

吉凤脯等药膳。长夏宜淡补:长夏时值夏秋之际,天热下降,地湿上蒸,湿热相缠,内应脾脏。应根据长夏之时采用淡渗之品利湿健脾,以达到气血生化有源。秋宜平补:秋季阳气收敛,阴气滋长,气候干燥,内应肺脏。此时五脏刚从夏季旺盛的代谢中舒缓过来,应进行阴阳平衡,以调节夏季脏腑功能的推敲,适宜食用菊花肉片、参麦团鱼、玉竹心子等药膳。冬宜温补:冬季天气寒冷,阳气深藏,内应肾脏。此时应根据冬季封藏的特点,以温热大补之品来滋补人体气血阴阳之不足,使脏腑的气血旺盛,适应自然界的變化,适宜食用归芪鸡、龙马童子鸡等药膳。一年四季,不论何时,都必须重视保养脾胃之气。脾胃为后天之本、气血生化之源。只有脾胃的消化吸收功能好,药膳才能充分吸收、转化。

除四季对人体的影响外,地理、环境、生活习惯的不同,也不同程度地影响着人们的生理、疾病等问题,因而必须辨证施膳。

(二) 以传统的烹调艺术为手段

药膳由药物、食物和调料三部分组成,它是取药物之性,用食物之味,药助食力,食借药威,二者相辅相成,相得益彰。因此药膳既不同于一般的中药方剂,又有别于普通的饮食,它是一种有药物功效的美味食品,能治病、强身、抗老的特殊食品。

由于中药汤剂多有苦味,故民间有“良药苦口”之说。有些人,特别是儿童,多畏其苦而拒绝服药。而药膳使用的多为药、食两用之品,且有食品的色、香、味等特性,即使加入了部分药材,由于注意了药物性味的选择,并通过与食物的调配及精细的烹调,仍可制成美味可口的药膳,故谓“良药可口,服食方便”。

药膳的主要原料是药物和食物。它必须寓药于食,寓性于味,融药物功效与食物味于一体。因此,它也就必须以精湛的烹调艺术为手段,借助炖、焖、煨、蒸、煮、熬、炒、卤、烧等中国传统的烹调方法,同时按患者身体的需要进行中药的调补、选料。对所选用的中药应根据药物的不同,采用不同的炮制、加工方法及分离提取法,以保证制成的食品既具有一般美食的色、香、味、形,又可在享受美味的同时达到治病、保健和强身的目的。由于药膳在组成上的特殊性,使其在制作方面具有独特的方法。药膳烹调是依照中医理论和用药要求,根据药物的性能,应用食品烹调 and 药物炮制加工技术而成的一套特殊的制作方法。因此在制作上除了要具备一般的烹调技术外,还应掌握中医药的基本理论和药物炮制方法。如“天麻鱼头”的制作,其方法是先将天麻用川芎、茯苓等药物炮制后,再用米泔水浸泡,然后放入米饭内蒸透,切片后置于鱼中,加入调料蒸制而成。

(三) 以治病、保健和强身为目的

自古以来,人们就很重视饮食对人体的作用。《黄帝内经·素问》一书中强调“人以水谷为本”,指出“营者,水谷之精气也,和调于五脏,洒陈于六腑……卫者,水谷之悍气也”,唐代名医孙思邈指出,“夫含气之类,未有不资食以存在”。宋代陈直认为,“主身者神,养气者精,益精者气,资气者食。食者生民之天,活人之本。故饮食进则谷气充,谷气充则气血盛,气血盛则筋力强……若有疾患,且先食医之法,审其疾状,以食疗之,食疗未愈,然后命药,贵不伤其脏腑也”(《养老奉亲书》)。金代刘完素也强调,“胃为水谷之海,喜谷而恶药,药之邪所入,不若谷气先达,故治病之法,必以谷气为先……辨生死之候者,谓安谷则生。凡明胃气为本,以此知五味能养形也”(《素问病机气宜保命集》),等。可见历代医家对饮食物的作用已有较为清楚的认识。

药膳除有防病治病之用外,较多地应用于中医扶正固本方面,所用的药物和食物,如人参、黄芪、当归、阿胶、枸杞、山药、大枣、鸡、鸭、猪肉、羊肉等,能滋养强壮身体、补气血阴阳、

增强正气、治疗体虚。经现代药理初步研究证明,某些滋补品具有增强机体生理功能的作用,改善细胞的代谢和营养,对神经内分泌的调节功能和机体的各种自卫机制也有一定的作用,并能增强机体的自稳状态,提高抗病免疫力,改善心肺功能和造血系统的功能,促进血液循环。如黄芪可延长细胞的生长寿命,人参能促进核酸合成,并能加强大脑皮质的兴奋和抑制过程,提高大脑功能的灵活性,减少疲劳感,还能促进抗体的形成;黄芪、灵芝、山药等能增强吞噬细胞的功能,促进机体产生干扰素,且能提高白细胞的数量及吞噬功能。此外,药膳中还含有人体代谢所必需的营养素,能有效地补充人体能量和营养物质,调节机体内物质代谢,从而达到滋补强身、防病、治病、延寿的作用。但是在用膳时,应本着“因人施膳,因时施膳”这一基本原则,才能使药膳更有效、更充分地发挥作用。

五、药膳的应用原则

(一) 辨证论治的基本原则

辨证论治就是运用“四诊”(望、闻、问、切)的手段,全面了解患者所出现的症候(症状和体征),然后通过这些症候,进行分析,弄清疾病发生的原因,推断疾病的部位和性质,结合患者的体质,确定运用哪种治疗方法,选用什么样的方剂和药物,对证治疗。用药如此,在药膳的选择上也应如此,也必须运用辨证的方法及论治的原则,采取相应得当的治疗方法,选择适宜的药物和食物,配制成药膳,方能取得预期效果。

作为辨证论治的具体体现,中医提出“同病异治,异病同治”的概念,意思是说,同一种疾病或症状,发生在不同的人身上,处于不同的病程阶段,其症候性质不一样,阴虚者当滋阴,阳虚者当温阳,治疗方法,选方用药截然相反。这就是同病异治。不同的疾病,发生在不同的人身上,若其证候性质相同,是阴虚的则滋阴,是血瘀的则活血,治疗方法、选方用药可以完全相同或大致相似。这就是异病同治。可见中医治病,重症轻病。药膳治病,本是中医治疗手段的一种,当然应当遵守辨证的基本原则。

如何掌握辨证论治的基本原则呢?按照中医的辨证论治理论,证的分类很多,按八纲辨证有表里、寒热、阴阳、虚实的不同,按脏腑辨证有心、肝、脾、肺、肾以及六腑证的不同。作为选择药膳的依据,我们这里仅把最主要、最常见的证型作一概述,尤其着重于药膳常用的虚证的描述。

1. 虚证 药膳中选用的中药最多见的是补益类中药。正气不足常分气、血、阴、阳虚弱四大类型。

(1)气虚证:气短自汗,懒惰,语音低微,面色苍白,肢体倦怠,舌质淡,苔薄白,脉虚大无力。五脏气虚还各兼见食少、便溏、食后脘胀、内脏下垂、失血脾气;如气虚证兼见心悸、气短、心前区闷满或痛、脉结代或细弱,为心气虚,可选用人参、西洋参、刺五加等制作药膳补益肝气;如气虚证兼见腰腿酸软、小便频清,甚至失禁,为肾气虚,可选用菟丝子、五味子等温肾化气。

(2)血虚证:面色萎黄或淡白,唇、舌、指甲色淡,毛发枯落,舌质淡,脉沉细。血虚证常见于心、肝二脏。如血虚证兼见心悸、烦躁、健忘、失眠多梦、脉细或结代,为心血虚,可选用夜交藤、合欢花、柏子仁等制作药膳补养心血;如血虚证兼见惊惕头晕、易怒、目暗、肢体麻木震颤、经少经闭、脉细弱,为肝血虚,可选用当归炖乌骨鸡、阿胶猪肝羹、酸枣仁粥等补养肝血。

(3)阴虚证:潮热盗汗,心烦失眠,口干咽燥,颧红,舌红少津,脉细数。如兼见干咳无痰、咽干声哑,有肺阴虚,可选麦门冬、沙参、梨子、冰糖等制作药膳滋养肺阴;如阴虚证兼见舌尖

红或口舌生疮,为心阴虚,可选用生地、玉竹等制作药膳滋养心阴;如阴虚证见惊惕头晕、易怒,为肝阴虚,可选用山萸肉、女贞子、枸杞子等制作药膳滋养肝阴;如阴虚证兼见腰疼、下肢酸软、耳鸣耳聋、发脱齿摇、梦寐遗精、眩晕健忘等症,为肾阴虚,可选用熟地黄、桑寄生、枸杞子等制作药膳滋养肾阴;如阴虚证兼见不思饮食、大便燥结或干呕呃逆,为脾胃阴虚,可选用太子参、麻仁、麦门冬等制作药膳滋养脾胃之阴。

(4)阳虚证:形寒怕冷,四肢不温,舌质淡,胖润齿痕,脉细弱。如兼见心气虚证候,为心阳虚,可选用桂枝、炙甘草等制作药膳温振心阳;如阳虚证兼见脾气虚之症状,及腹中冷痛、口泛清水、白带清稀而多,为脾阳虚,可选用干姜、白术等制作药膳温补脾阳;如阳虚证兼见腰疼、下肢酸软发凉,为肾阳虚,可选用附片、肉桂等制作药膳温肾壮阳、充髓海;如肾阳虚证见大便溏泄、完谷不化者,可选用山药、干姜等配合温肾止泻;如肾阳虚证兼见水肿、夜尿多,可选用益智仁、五味子等制作药膳缩泉固肾;如肾阳虚证兼见滑精,可选用金樱子补肾固精;如肾阳虚证兼见阳痿、早泄,可选用鹿茸、淫羊藿、韭子等制作药膳温肾助阳。

2. 实证 常见的慢性病不仅仅是正气不足,也还夹有实邪,常见有气滞、血瘀、痰湿、虚火等。配制药膳时在一定阶段也必须选用行气、化瘀、消痰、降火诸品,不可一味用补。

(1)气滞:若见到胀满、憋闷、疼痛、舌质较黯、脉弦等证,为气滞证。兼见喘促、咳逆、胸闷,为肺气壅滞,可选用莱菔子、紫苏子、枇杷叶等制作药膳肃降肺气;如气滞证兼见脘腹胀满疼痛、呕吐、噎气、呃逆、矢气,为脾胃气滞,可选用佛手柑、陈皮等制作药膳理气健脾止痛;如气滞证兼见胸胁及少腹胀满窜痛、呃逆、女子乳房胀痛、痛经,为肝气郁滞,可选用代代花、桂花、合欢花等制作药膳疏肝理气。

(2)血瘀:若见到疼痛部位固定,刺痛或钝痛,按之有肿块,到局部麻木,唇黯,舌有紫斑,脉涩,为血瘀证。如兼见阵发性心前区疼痛或刺痛,或牵引肩痛,舌尖有瘀斑,脉结代,为心脉瘀阻,可选用桃仁、生地、葛根等制作药膳通脉活血;如血瘀证兼见右肋下刺痛或钝痛,肢体时有麻木等症,为肝脉瘀滞,可选用玫瑰花、甲鱼壳、当归等活血逐瘀。

(3)痰饮、水湿:若见到寒邪内侵与水湿、痰饮相凝、舌质淡、苔白滑润、脉沉迟或紧,为寒湿痰饮证。如兼见喘咳痰多清稀、胸疼、恶寒、无热者,为水寒射肺,可选用桂心煮粥温阳化饮;如兼见心悸、心区疼痛,遇寒尤甚,或水肿,为水寒凌心,可选用桂枝、薤白等温阳化水;如兼见脾寒脘腹满闷、头身困重、呕吐清水、大便溏薄、白带清稀而多,为寒湿困脾,可选用山药、白术、茯苓等健脾利湿;如兼见少腹胀痛、疝气、睾丸胀坠而湿冷,或巅顶头痛,而呕吐涎沫,为寒滞肝脉,可选用吴茱萸、茴香等暖肝散寒。

(4)火热:若五脏功能失调而出现火热内炽、舌质红、苔黄、脉滑而数,为阳旺内火证。如兼见咳痰黄稠,甚或带血,胸部热痛,鼻咽干燥,为肺热内蕴,可选用桑叶、桑白皮等清泻肺火;如兼见心烦、失眠、舌体糜烂,为心火上炎,可选用竹笋、竹叶等清泻心火;如兼见口唇红肿、口腔溃疡、口渴欲凉饮、脘腹热痛、大便秘结,为脾胃蕴热证,可选用麻仁、苦瓜等泻热通便;如兼见头痛眩晕、目赤多眵、急躁易怒、口苦、耳鸣、胁肋作痛,为肝火上炎,可选用菊花、石决明等制作药膳清泻肝火。

辨证选用药膳是人们合理使用药膳的原则,就药膳与病证性质而言,则当采用寒者热之、热者寒之、虚者补之、实者泻之的总原则,结合脏腑辨证的特点,选择相应的药物和食物配制药膳,再结合季节变化、体质特点、地理环境和生活习惯等,从整体去把握选择,一般可收到预期的效果。

(二) 根据人体体质选用药膳

我们在选用药膳时还要考虑人的体质因素,特别是基本健康的人选择药膳,应因人而异。所谓药膳的因人而异,是指根据人的自然状况,如体质、年龄、性别、职业等方面的具体情况,来选择适宜的药膳。这些因素中尤其以体质最为重要。

体质,即机体素质,是指人体禀赋于先天,受后天多种因素影响所形成的与自然、社会环境相适应的功能和形态上相对稳定的固有特性,它反映机体内阴阳运动形式的特殊性,这种特殊性由脏腑盛衰所决定,并以气血为基础,在一定程度上预示并决定机体的健康状况朝着某种趋势发展。因此,人们在养生防病的过程中往往采取种种措施对各种发生偏差的体质状态进行矫正,以防朝着某一类疾病的方向发展。药膳当然是调整体质朝着有利于健康状况发展的有效手段。

由于先天禀赋有强弱,饮食气味有厚薄,方位地势有差异,贫富贵贱苦乐各不相同,从而形成了各种各样的体质特点,大致可归纳为以下几种:

1. 阳盛质 凡强壮的、声高气粗的、好动的人,属于阳盛体质。此类人平常喜凉怕热,神旺气粗,口渴喜冷饮,尿黄便结,病则易发热,脉洪数有力,舌红,苔薄黄。阳盛体质之人不易患病,一旦患病,多为急性病、暴发病。因此,选择药膳时,应选择滋阴生津的药物,如生地、麦冬、玉竹、枸杞子,以及清火寒凉之品,如菊花、银花、莲心等,结合清淡饮食,如清凉去火的蔬菜,性凉不腻的兔肉、元鱼、鸭肉、河鱼等,清其过盛之热,抑其过旺之阳,适当补其耗伤之阴。

2. 阴虚质 这类人形多瘦小,面色多偏红或有颧红,常有灼热感,手足心热,口咽干燥,多喜饮冷,唇红微干,冬寒易过,夏热难熬,舌红苔少,或无苔,脉细弦。选择药膳时,应不滋腻、不蛮补、不刺激、不过寒凉,诸如何首乌、枸杞子、石斛、太子参、山药、薏苡仁等药物,结合清凉平淡之饮食,缓补其阴。

3. 瘀血质 平素面色晦滞,口唇色黯,肌肤甲错,常有出血倾向,皮肤局部瘀斑,或身体某部刺痛,固定不移,或有包块,推之不动,舌质紫黯或有瘀点。此类人选择药膳,其功重在畅通气血,可选用活血养血之品,如赤芍、川芎、当归、红花、桃仁、大黄、甲鱼壳等,亦可用银杏黄酮类物质浸酒,药可与乌骨鸡、猫肉等配合制作菜肴。

4. 痰湿质 平素身体肥胖,或嗜食肥甘,嗜睡懒动,口中黏腻,食量较大,多汗,既畏热,又怕冷,适应能力差。病则胸脘痞闷,咳喘痰多;或恶心呕吐,大便清泄;或四肢水肿,按凹陷,小便不利或浑浊;或头身困重,关节疼痛重浊,肌肤麻木不仁;或妇女白带过多,苔多腻,常见灰黑,或舌面罩一层黏液,脉濡或滑。此类人易致阳气不足,选择药膳宜温养调补,可用附片、肉桂、党参、黄芪等与鸡肉、牛肉、羊肉等制作药膳,但忌食用过量,热量过剩,酿生痰湿。

5. 气郁质 此类人形体消瘦或有偏胖者,面色萎黄或苍黯,平素性情急躁易怒,容易激动,或抑郁寡欢,胸闷不舒,时欲叹息。病则胸胁胀痛或窜痛;或乳房小腹胀痛,月经不调,痛经;或咽中梗阻,如有异物;或气上冲逆,头痛眩晕;或腹痛肠鸣,大便泄利不爽,舌淡红,苔白,脉弦。这类人相当于现代所称的抑郁型或抑郁质。选择药膳时,应当疏肝理气,畅达情志,如香橼、佛手、陈皮、白芍、甘草、合欢花、玫瑰花、桂花、茉莉花等。剂型膳谱宜选羹、汤、饮、酒,忌用香、辣、煎、炸、熏、烤之类。

(三) 根据气候、地理选用药膳

人与天地相参。人生活在大自然中,与自然息息相关,人类的生存有赖于大自然提供的

各种条件,人体与外在自然环境之间存在着既对立而又统一的关系。因此,中国传统养生学早就提出“顺乎自然”的养生方法,药膳食疗是我国传统的养生方法之一,无疑也应遵循“顺乎自然”的法则。因为药膳亦如菜肴,既有明显的地方风味特色,也有明显的季节变化特点。

先讲药膳顺应四时的选择。这在《黄帝内经》中已作了明确的交代,就是为了“春夏养阳,秋冬养阴,以从其根”(《素问·四气调神大论》)。意思是说,在春夏季节应注意保养阳气,秋冬季节应注意保养阴液,这样就能适应四时阴阳(气候的寒热、寒凉为阴,温热为阳)的变化。药膳选择必须适应这四时气候变化的规律,才能起到良好的养生作用。

春季是万物生发的季节。《汉书·律历志》说:“少阳东也,东者动也,阳气动物,于时为春。故君子当审时令,节宜调摄,以卫其生。”意思是说,春天阳气渐渐升腾(少阳),故能使自然界万物萌动,生机勃勃。外界温暖的气候影响着一切生物,善于养生的人们也应根据这一时令的特点,进行适宜的调养,以保障生命的正常活动。故《黄帝内经》说:“春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣。”此时人体生理功能为了适应这一季节气候的变化,表现在皮肤腠理(汗孔)由冬令的致密而转疏松,在五脏中肝的功能活动也较为旺盛。故《内经》言“东方青色,入通于肝”,后人又有“春旺于肝”之说。因此,春季的药膳食疗就应适当地注意到这一生理特点。唐代医家孙思邈提出调味“省酸增甘,以养脾气”,即少吃酸味食物,多吃甜食,以防肝旺克脾,也就是后世养生家提出的“春宜甘平”的养生法。其性味甘平或有清肝作用的药物和食物有:茯苓、山药、薏苡仁、莲子、胡萝卜、菠菜、鱼鳔、银耳、木耳、牛乳、枸杞、荠菜、马兰头、芹菜、小白菜、荸荠、菊花脑等。对于肝气不旺、气血两虚者,亦可选择黄芪、当归、人参、桂圆、乌骨鸡等进补,以助肝气顺应自然而正常升发。

夏季是一年中天气最热的季节,也是万物生长最茂盛的时令,故《内经》概括为“夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实”。意思是说,夏天三个月中,是万物繁荣秀丽的季节,其时天空热气下降,地气因而上升,自然界植物大多开花结果。夏季对五脏中心的功能活动有一定帮助,故有“南方赤色,入通于心”的说法。夏季的药膳食疗就应当注意到这一特点。孙思邈提出“夏宜增辛减郁苦”。他认为,夏季心火当令,而苦味入心,苦多则助心火,而伐克肺金,为了防止肺气受伤,故多吃辛味,以补肺气。但这未免有些机械。现实生活中,夏季膳食还是以甘寒清凉为宜,再适当地加些清心火的食物,以防中暑。另外,夏天多数人食欲减退,脾胃功能较为迟钝,故此时的药膳在总体要求上以“清淡甘平”为原则,有助于开胃消食,若此时运用冬令药膳,过进肥甘腻补之物,则致呆胃伤脾,影响营养消化吸收,有损健康。所以,夏令宜选择甘寒清补之品,如西瓜、黄瓜、绿豆、冬瓜、丝瓜、西红柿、杨梅、鳝鱼、玉竹、百合、薏米、黄精、石斛、麦冬、沙参、太子参、西洋参、枸杞等。

秋季三月,炎暑渐消,金风送爽,万物由生长渐趋凋谢,处于收获的季节。人体也同样处于收获时期。机体已由活跃、外向、支付阶段,转变过渡到沉静、内向、积蓄的阶段。由于夏季消耗多吸收少,秋季要重视补充营养,调整功能,为冬季的藏精做好充分准备。秋天阳气由升浮趋于沉降,生理功能趋于平静,气候逐渐转凉。此时,宜注意补益甘味以益气。秋高气爽,气候偏于干燥,秋气应肺,燥气可耗伤肺阴,使人产生口干咽燥、干咳少痰、皮肤干燥、便秘等症状,这些都是秋季使用药膳进补时应注意的因素。根据“燥者濡之”的原则,秋天药膳应选择甘润养肺类补品,甘润温养,既不可过热,又不能太凉,总体上以不伤阳、不耗阳为度。同时,在味型的选择上,秋令肺气旺,辛味入肺能补肺气,故应少吃辛味,以免肺气过旺而克肝;多吃酸味,以助肝气,可以抵御肺旺的克伐。酸味与甘味相合,则可化生阴津以濡润秋燥,所以,秋季制作药膳常选的药物和食物有百合、沙参、麦冬、阿胶、石斛、银耳、甘蔗、柿

子、梨、荸荠、菠萝、香蕉等。

冬季三月,气候由凉爽转为寒冷,自然界万物凋谢;朔风凛冽,甚至大雪纷飞,银装素裹,有些生物则自行蛰伏(亦谓冬眠)。《黄帝内经》概括冬季特点称“此谓闭藏,水冰地坼,无扰乎阳”。意思是说,冬季三个月,自然界万物处于闭藏状态,气候严寒,水结冰,地冻裂,阴寒盛,阳气衰。故冬季药膳应很好地保护阳气,祛除阴寒,宜遵循温补的原则。冬季对五脏中肾的功能活动有一定帮助,所谓肾气旺于冬。又因咸能入肾,肾主蛰藏,咸多伤肾,故冬季药膳不宜用咸太过。冬季药膳尤要注意温补肾阳,以助肾藏精气,从而化生气血津液,促进脏腑的生理功能。但要注意制作药膳选择药物和食物时应温而不散、热而不燥,如牛肉、羊肉、狗肉、桂圆、红枣、核桃肉、鹿茸、胎盘、冬虫夏草、人参、肉苁蓉、桑寄生等。

药膳顺乎自然,除了顺应四时气候外,还应顺应四方地理。这在中国烹饪的风味流派里已经得到充分体现。中国素称烹饪王国,菜肴丰富多彩,口味各具特色,以至形成菜系、风味,与各地地理环境因素密切相关。药膳亦然。譬如西北地区,地处多高原,而气候亦较寒冷、干燥,药膳宜温、宜润。因为地区寒凉,易伤人体阳气,故宜用温性的药物和食物制作药膳以胜寒凉之气,又由于多风致燥,燥则易伤人体阴液,伤阴液则易使人皮肤、黏膜干燥,故宜用滋润的药物和食物制作药膳以胜其干燥。其具体药物和食物可参照秋季和冬季选择有关补品。

东南地区地势较低洼,气候亦较温热、潮湿,药膳宜甘、宜辛、宜燥。因为地区潮湿,易伤脾胃,困顿阳气,故宜用甘淡渗湿、辛燥、散湿、甘味健中之品,如茯苓、山药、薏米、砂仁、扣仁、陈皮、白术、扁豆、大枣、莲子等。

药膳在顺乎地理的同时,融入了各地菜肴风味特色,譬如以四川、广东、江苏、山东四大菜系为代表的中国烹饪药膳的风味也各有特色,如四川风味的药膳有陈皮牛肉、桃仁鸡丁、姜汁热味鸡、魔芋烧鸭、五香鳝鱼、红烧甲鱼、蜜汁山药糕等,药物常选辛香发散之品,以发散山区丘陵地带常常侵犯人体的秽浊之气;广东风味的药膳有原煲狗肉、鲜莲冬瓜盅、党参鸡脚炖花鹿、虫草凤翅炖山甲、乌鸡菊花烩五蛇等,药物和食物常选清凉败毒之品,以消南方暑热毒气;江苏风味的药膳有鸡头鳖汤、红烧冰糖甲鱼、芹菜冬笋山鸦片、洋参乌骨鸡、黄芪气锅鸡等,常选择甘味补气健脾渗湿之品,以祛环境之水湿,消脾胃之内湿;山东风味的药膳有德州扒鸡、单县羊肉汤、竹笋海参、临沂糝、珊瑚白菜墩等。北京的五子鹿肉串、玄驹球、参茸鹿鞭、姜石猴头等药膳适应了北方地区的寒冷,湖南的药蒸肚片、药蒸牛鞭、龟羊汤、冬菇菊花荸荠、板栗煨鸡等都是当地有名的风味药膳。

从上述可知,季节气候、地理环境对药膳风味的影响是比较大的,当然,最终还是通过人的体质表现出来,因为这些外界环境因素长期作用于人体,就必然引起人的体质变化,根据季节气候、地理环境变化选择药膳,无疑是帮助人们抵御外界对人体产生不良作用的因子,对正常人来说是一种预防手段,对体质已经产生变化或发生病症的人来说,这也是一种辅助治疗手段。所以,如何选择药膳,既要因人而异,根据体质、病症的不同而选择,又要顺乎自然,根据季节、地区的不同而选择。只有这样,才能使药膳真正有益于人体的健康。

六、药膳的分类

为了便于掌握和运用,我们结合历代医籍中的分类方法和现代分类思想,按药膳食品的作用、制作方法、应用及原料等方面进行如下分类。

(一) 按作用分类

古代有许多医书,均按药膳食品的医疗作用分类。

1. 保健类 此类药膳是根据用膳者的生理、病理特点而制作的一种属于药性平和、起增进健康和抗衰老作用的膳食。它主要是通过提高机体免疫功能和协调功能来达到促进发育、调理气血或抗老延年的目的。可分为儿童保健药膳、妇女保健药膳和老年保健药膳。常见类型有:

- (1)减肥类:如参芪鸡丝蒸冬瓜、盐渍三皮、减肥酒酿。
- (2)美容类:如笋烧海参、青蒿甲鱼汤、佛手笋尖、香椿拌豆腐。
- (3)增智类:如健脑粥、增智果脯、山药乌鱼卷、菖蒲鹿角菜。
- (4)增力类:如鹤草红枣蜜膏、人参鸽蛋、山药黄精豆腐羹。
- (5)明目类:如蒙花羊肝、决明子菊花饮、青葙烧野鸡。
- (6)聪耳类:如葛粉鳗肉熘腰花、清肝聪耳李实脯、腐竹炒苋菜、刀豆煮芥菜根。
- (7)固齿类:如石斛绿茶饮、马齿苋骨髓粥、滋肾固齿八宝鸭。
- (8)美发类:如美发果冻、三豆乌发米糕、养血健发果脯、首乌胡萝卜。
- (9)增肥类:如茯苓夹饼、参芪毛豆角、百合栗子鸡。
- (10)益寿类:如仙人粥、魔芋豆腐羹、益寿胶冻。

2. 预防类 中医历来主张“不治已病治未病”。常见的预防类药膳有:①预防流感:如姜葱鲩鱼;②预防咽炎:如蜜饯甘草樱桃;③预防中暑:如清暑豆汤;④预防泻痢:如马齿苋粥。春季气候易变,常罹患感冒,可服用相应的预防类药膳加以预防。夏季易患腹泻,即可运用马齿苋粥防御;为防中暑,可用绿豆汤之类,发挥其即清热又防暑湿的功用。秋季干燥,呼吸道易感性强,便可用百合、贝母、杏仁类膳食防御。冬令寒冷,可用当归、黄芪、羊肉类药膳而增强机体抵抗力。

3. 治疗类 此类药膳是针对患者的病情需要而制作的一种起治疗作用或辅助治疗作用的膳食。它可以通过长期服用而达到治疗疾病的目的,最适宜于慢性病患者。常年食用,既有疗效,又可免遭服药之苦。常用治疗药膳食品有:

- (1)发汗解表类:如姜糖饮、葱豉黄酒汤、薄荷糖、桑菊薄竹饮、香薷饮、绿豆粥等。
- (2)祛痰止咳平喘类:如止咳梨膏糖、柿霜糖、鸡蛋炸萝卜、银耳羹、瓜蒌饼、糖橘饼等。
- (3)消导化积类:如消食茶膏糖、山楂肉干、果仁排骨、芸豆卷、五香槟榔、益脾饼等。
- (4)清热解毒类:如银花露、西瓜番茄汁、五汁饮、七鲜汤等。
- (5)祛寒类:如附子羊肉汤、当归生姜羊肉汤、荔枝粥等。
- (6)祛湿类:如豆蔻馒头、茯苓包子、苡仁红枣粥、蚕豆糕、香椿鱼等。
- (7)泻下类:如蜂蜜香油汤、土豆蜜膏、杏炖雪梨等。
- (8)补益类:如田七蒸鸡、归参炖母鸡、冬虫夏草鸭、桂圆等。
- (9)理气止痛类:如陈皮鸡、丁香鸭、佛手酒、香砂糖等。
- (10)理血化瘀类:如参枣汤、当归鸡、红枣黑木耳汤、牛肉胶冻等。
- (11)息风镇惊类:如菊花肉片、天麻鱼头、菊花绿茶饮等。
- (12)安神镇静类:如枣仁粥、玉竹心子粥、葱枣汤等。

4. 康复类 人体大病之后,机体衰弱,便可用扶正固本类药膳,促使早日康复。针对疾病和损伤所造成的功能障碍,通过药膳调摄,使之尽可能恢复或接近正常水平。主要包括:①有脏腑功能衰退的气虚证者常用参芪晶、归参山药糊等;②因阴血不足、脏失于濡养而有

血虚证者常用玫瑰花烤羊心、糖渍鲜龙眼、猪肝红枣羹等；③有阴虚阳亢证候者常用冰糖黄精汤、蛋饊鲜桑椹、饊糖精等；④有阳虚证候者常用归地烧羊肉、良姜炖鸡块等；⑤津液不足者常用脂酒红枣、桂圆参蜜膏等；⑥病后失于调理，或情志刺激，或劳倦过度、饮食不节、房事所伤者常用制黑豆、制杏仁、八宝米饭等。

（二）按药膳食品性状分类

1. 菜肴类 以蔬菜、肉类、鱼类、蛋类等为原料，配以一定比例的药物烹调而成的，既有普通菜肴的色、香、味、形，又有治疗保健功效。主要包括：①冷菜：如芝麻兔、山楂肉干；②蒸菜：如虫草金龟、阳春肘子；③煨炖菜：如枣蔻煨肘、八宝鸡汤；④炒菜：如首乌肝片、杜仲腰花；⑤卤菜：如丁香鸭、陈皮油烫鸡；⑥炸菜：如软炸白花鸽、山药肉麻元等。

2. 米面类 以稻米、糯米、小麦面粉为基本原料，加入一定量的补益或性味平和的药物，经煮、蒸等方法加工而成的米饭或面食。如豆蔻馒头、人参菠饺、八宝粥、人参汤圆等。

3. 饮料类 将药物和食物原料经浸泡或压榨、煎煮或蒸馏等方法处理制成的饮料。它包括药膳饮液（如桑菊薄荷饮、鲜藕姜汁、山楂核桃茶、银花露等）和药酒（如人参枸杞酒、三蛇酒等）。

4. 罐头类 将药膳食品按罐头生产工艺制成的一种特殊食品。与其他类型的药膳食品比较具有可长期存放、利于运输保管等优点。如虫草鸭子、雪花鸡等药膳罐头制品。

5. 汤羹类 以肉、蛋、奶、海味等原料为主体，加入味美或味淡的药料经煎煮、浓缩而成的较稠厚的汤液。如归参鳝鱼羹、天麻猪脑羹等。

6. 精汁类 将药物和食物原料用一定的方法提取、分离，制成有效成分含量较高的液体。如虫草鸡精、人参精等。

7. 糕点类 将适于制作糕点的药物制成糕点食用。如八珍糕、茯苓饼、淮药金糕、枣泥桃酥等。

8. 糖果类 将加工后的药物加入熬炼的糖料中混合后制成糖果食用。如薄荷糖、山楂软糖等。

9. 蜜饯类 以植物的果实、果皮类的新鲜或干燥原料经药液、蜂蜜或糖液煎煮后，再加蜂蜜或白糖制成。如蜜饯山楂、糖橘饼等。

10. 其他 如桂花核桃冻、川贝酿梨、淮药泥、桃杞鸡卷等。

七、药膳学的发展展望

药膳学具有悠久的历史，数千年来，在防病、治病、养生、抗衰老等方面起了重要作用。它不仅内容极其丰富，而且具有广泛的实践意义。为使这一宝贵遗产兴旺发达，必须在发掘、整理、继承的基础上，进一步运用现代科学理论和技术，逐步阐明药膳学的科学理论依据，提高其使用的可靠性，以使其不断发展、更加完善。

随着社会的发展，药膳的生产、经营将以崭新的形式出现。但是在有关药膳的科学研究方面还有待于进一步运用中医药理论，结合药理、药化、现代医学等科学知识进行探索，质控指标和制作工艺仍需运用现代的检测手段摸索和制定。只有这样才能使药膳更具有科学性和可靠性，药膳品种才能不断更新，药膳事业才能兴旺发达。

（朱翠凤）

第十二章

保健食品与膳食补充剂

第一节 保健食品

一、保健食品的概念

保健食品(health food or functional food)于 20 世纪 90 年代初期首先在日本等亚洲国家兴起。初始阶段,保健食品的定义并不明确,到 90 年代以后,各个国家才开始制定相关的政策法规。其中,日本、美国已经分别于 1991 年和 1994 年将其纳入了政府化和规范化管理的轨道。我国卫生部 1996 年 6 月 1 日颁布的《保健食品管理办法》,对我国保健食品实行了监督管理和严格的审批制度,要求保健食品的配方组成及用量,必须具有科学依据,具有明确的功效成分以及有一定的保健功能。

在我国《保健食品管理办法》中,将保健食品定义为:“保健食品系指表明具有特定保健功能的食品。即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的的食品”;另外在我国国家标准 GB16740—1997《保健(功能)食品通用标准》中,将其定义为“保健(功能)食品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,能调节人体的功能,适于特定人群食用,但不可以治疗疾病为目的”。这两个定义很接近,都表明了保健食品除了具备食品的第一功能(满足人体对热能和各种营养素的生理需要)和第二功能(满足人们口味嗜好的要求,体现在色、香、味、形等方面)外,还有其突出的特性,即第三功能——含有一定的功效成分,能起到调节人体功能的作用。需要指出的是:“保健食品”一词是中国的名称,其他国家多称之为健康食品(health food)或功能性食品(functional food)。

二、保健食品的特点

保健食品应具备三个最基本的特征:①保健食品必须保证食用安全性;②保健食品必须带给食用者某种特定的健康利益或体现特定的保健功能,这种特定的健康利益或保健功能不属于已知营养素的营养作用,并可用现代的科学方法(最好在人体)验证;③保健食品不是药品,不能代替药品,不以治疗为目的。

(一) 保健食品首先是食品

保健食品必须是食品。这是合理的、有法制性和权威性的保健食品定义。关于食品必须具备的特征(或要求或条件),在中华人民共和国食品卫生法第六条有清楚明确的规定:“食品应当无毒、无害、符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状”。

(二) 保健食品要有保健功能

保健食品与普通食品的不同之处在于其特定的保健功能。这个保健功能是来自它特有的功效成分。保健食品的功能是纠正不同原因、不同程度的人体营养失衡,调节与此有密切

关系的代谢异常和生理功能异常,抑制或缓解有关的病理过程。强调保健功能是界定保健食品的主要要素,而保健功能是相对于食用者的机体状态而言,只有食用者存在某种功能异常,保健食品才能对他显示相应保健功能。例如有延缓衰老作用的保健食品只对已经产生衰老过程的中、老年人才显示此项功能,而对儿童毫无价值。

(三) 保健食品同药品有区别

保健食品不以治疗为目的,不追求短期临床疗效,不需医生处方,对适用人群无严格剂量限制,正常条件下食用安全,在评价其食用安全性时,不能权衡利益与危险。这是它与药品的本质区别。药品必须有药理作用,有严格的剂量限制。

三、保健食品的分类(categories of health food)

我国的保健食品一般都是复合配方,这符合我国中医学的用药原则。通过组方的配伍与组合,既能相辅相成,增强单味药原有的作用,又能消除或缓和其对人体不利的影响,从而收到预期的效果。所以中国的保健食品按其原料来分,大致可分为以下四类:

(一) 中国传统食物及药食同源类保健食品

中国传统饮食习惯中的一些食物也是中草药的药材。这类食物称之为药食同源的食物。近十余年来其中的大部分品种已被应用为保健食品的原料,并已研究出其所含的具有生理活性的功效成分及相应的生理功能。近年来在卫生部批准的保健食品中常用的药食同源类保健食品原料有五大类共 27 个品种,如苦荞麦、魔芋、山药、大蒜、南瓜、红花苜蓿、鱼腥草、螺旋藻、山楂、酸枣仁、陈皮、红曲、黑木耳等。

(二) 中草药类保健食品

卫生部公布了一批中草药和少数动物来源的中药名单,如根类(包括人参、西洋参等)、果或子类(包括枸杞子、决明子、火麻仁等)、全草类(如银杏叶、淫羊藿、芦荟、苦丁茶等)、花类(如蜂花粉、红花等)、菌类(灵芝、冬虫夏草等)。这是一大类具有东方医药传统特色的中国保健食品原料资源。包括:

1. 既是食品又是药品的物质 此类原料可不限食用。共 77 种,按其作用分为 9 类:

(1)健脾益气类:枣、山药、白扁豆、薏苡仁、甘草、茯苓、鸡内金;

(2)滋阴补血类:龙眼肉、百合、桑椹、黑芝麻、枸杞子;

(3)活血化瘀类:山楂、桃仁、红花;

(4)益肾温阳类:八角茴香、大茴香、刀豆、花椒、黑胡椒、肉桂、肉豆蔻、姜、益智;

(5)止咳平喘类:杏仁、白果、黄芥子;

(6)固涩安神类:芡实、莲子、酸枣仁、牡蛎、乌梅、淡竹叶;

(7)解表类:生姜、白芷、菊花、香薷、淡豆豉、薄荷、藿香、桑叶、蒲公英、胖大海、金银花、鱼腥草;

(8)理气类:佛手、莱菔子、陈皮、砂仁、薤白、丁香、香橼、橘红、紫苏、麦芽;

(9)其他:木瓜、赤小豆、青果、海带、莴苣、蜂蜜、榧子、乌梢蛇、蝮蛇、栀子、代代花、罗汉果、决明子、沙棘、郁李仁、火麻仁、鲜白茅根、马齿苋、芦根、荷叶、余甘子、葛根。

2. 可供研究应用的中药类

(1)健脾益气类:人参、刺五加、黄芪、白术;

(2)滋阴补血类:阿胶、地黄、木耳、玉竹、麦门冬;

(3)益肾温阳类:鹿茸、冬虫夏草、淫羊藿、胡桃仁;